GUSTAVE ROUSSY
CANCER CAMPUS
GRAND PARIS

DÉPARTEMENT D'IMAGERIE MEDICALE
CHEFFE DE DEPARTEMENT
PROFESSEURE

SERVICE D'IMAGERIE DIAGNOSTIC
PR C. BALLEYGUIER
CHEFFE DE SERVICE
Tél. : 33 (0)1 42 11 60 74
corinne.balleyguier@gustaveroussy.fr

CADRE DE DÉPARTEMENT
V. FORTE
Tél. : 33 (0)1 42 11 43 99
veronica.forte@gustaveroussy.fr

SECRÉTAIRE PRINCIPALE
S. SOCHET
Tél. : 33 (0)1 42 11 48 73
sophie.sochet@gustaveroussy.fr

SECRÉTARIAT MÉDICAL
SCANNER
Tél. : 33 (0)1 42 11 48 93
IRM
Tél. : 33 (0)1 42 11 48 54
MAMMOGRAPHIE
Tél. : 33 (0) 1 42 11 48 85
ÉCHOGRAPHIE
Tél. : 33 (0)1 42 11 60 78

IPP :
Né(e) le :

Examen réalisé le : /04/2025 à

Code protocole : TDM THX HIT D
Examen réalisé sur *: Siemens CT Force. N° d'agrément M940093. Mis en service le 09 juillet 2020*
Rapport validé par :

SCANNER THORACIQUE DE DEPISTAGE

INDICATION :

Scanner de dépistage à la recherche d'une lésion primitive pulmonaire. Facteurs de risques.

TECHNIQUE :

Réalisation d'une acquisition :

- Thoracique basse dose

Examen réalisé sans injection de produit de contraste

PDL : 31.22 mGy.cm

RESULTAT :

Absence de nodule pulmonaire suspect.
Absence de condensation parenchymateuse suspecte de lésion primitive
Absence d'adénopathie médiastinale, des chaînes mammaires internes ou axillaires bilatérales.
Absence d'épanchement pleural.
Absence d'épanchement péricardique.
Absence d'anomalie des gros vaisseaux.
Absence d'anomalie pariétale.
Absence de lésion osseuse lytique ou condensant suspecte.

Calcification des artères coronaires :

Score calcique : 326.1

Autres lésions de découverte fortuite :

Absence d'anomalie sur les coupes abdominales hautes.

CONCLUSION :

Pas d'image suspecte de lésion primitive pulmonaire.

_____

Courrier rédigé avec un logiciel de reconnaissance vocale pouvant comporter quelques imperfections orthographiques.

Signé & Validé electroniquement par : ł